

DIVERTICULITIS AGUDA

Marta Pérez González, Giancarlo Candela Ganoza, Diego T. Enjuto Martínez.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad diverticular está definida por la presencia de pseudodivertículos o herniaciones de la mucosa y submucosa a través de puntos débiles de la pared muscular del colon. Dentro de ella se distingue entre diverticulosis, que hace referencia a la presencia de dichos divertículos, diverticulitis aguda, cuando existe inflamación de un segmento colónico, y diverticulitis crónica.

La prevalencia de la diverticulosis es difícil de establecer, pero es conocido que aumenta con la edad siendo inferior a 5% en los pacientes menores de 40 años y de entre el 65-80% a partir de los 70.

En cuanto a su etiología, no es del todo conocida, pero el hecho de que sea una enfermedad más prevalente en los países occidentales hace que la teoría más aceptada sea la de que es multifactorial, existiendo una predisposición genética a la que se sumarían factores ambientales y dietéticos. En este sentido, se han identificado como factores de riesgo a la dieta pobre en fibra y la obesidad, así como el descenso del ejercicio físico.

La distribución de los divertículos a lo largo del colon no es homogénea, siendo la localización más frecuente el sigma, seguida del colon descendente. Su presencia en el colon derecho se objetiva con mayor frecuencia en países asiáticos.

Se estima que del total de pacientes con diverticulosis, solo un 15-20% desarrollarán complicaciones derivadas de la misma, y más concretamente episodios de diverticulitis aguda. De estos, el 75% comprenderán episodios de diverticulitis aguda no complicada.

DIAGNÓSTICO

Clínica

La sintomatología típica de la diverticulitis aguda incluye el dolor en fosa iliaca izquierda y signos variables de peritonitis localizada (defensa, signo de rebote...) asociados a fiebre. Dependiendo de la localización del segmento de colon afecto, es posible que dicho dolor se localice en el hipogastrio, o incluso en la fosa iliaca derecha en casos de colon sigmoide redundante o diverticulitis de colon derecho.

En algunos casos el paciente refiere síndrome miccional asociado, que generalmente es secundario a cistitis por contigüidad. La presencia de neumaturia o fecaluria obliga a descartar una fístula colovesical en el seno de una diverticulitis crónica. Con relativa frecuencia es posible identificar una masa palpable que corresponde con el segmento de colon afecto.

Con el fin de descartar una diverticulitis aguda con perforación asociada, es necesario investigar la existencia de irritación peritoneal difusa, así como de signos de SIRS o shock séptico.

Laboratorio

- Hemograma
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, amilasa, bilirrubina total y fraccionada, PCR, procalcitonina.
- Coagulación

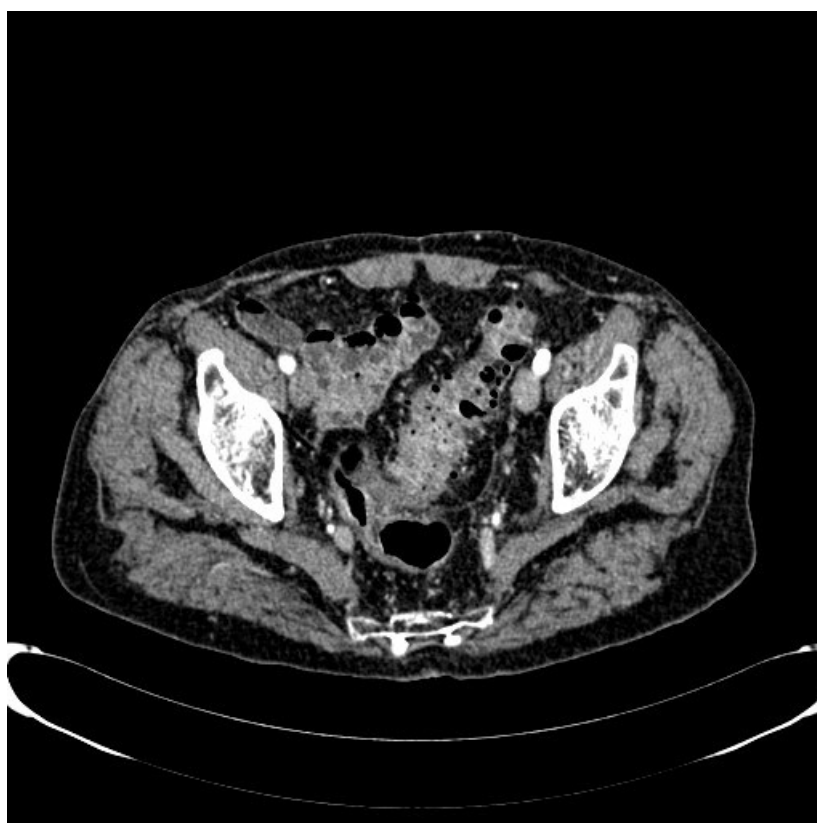
Es necesaria una analítica básica completa que incluya bioquímica general con PCR,

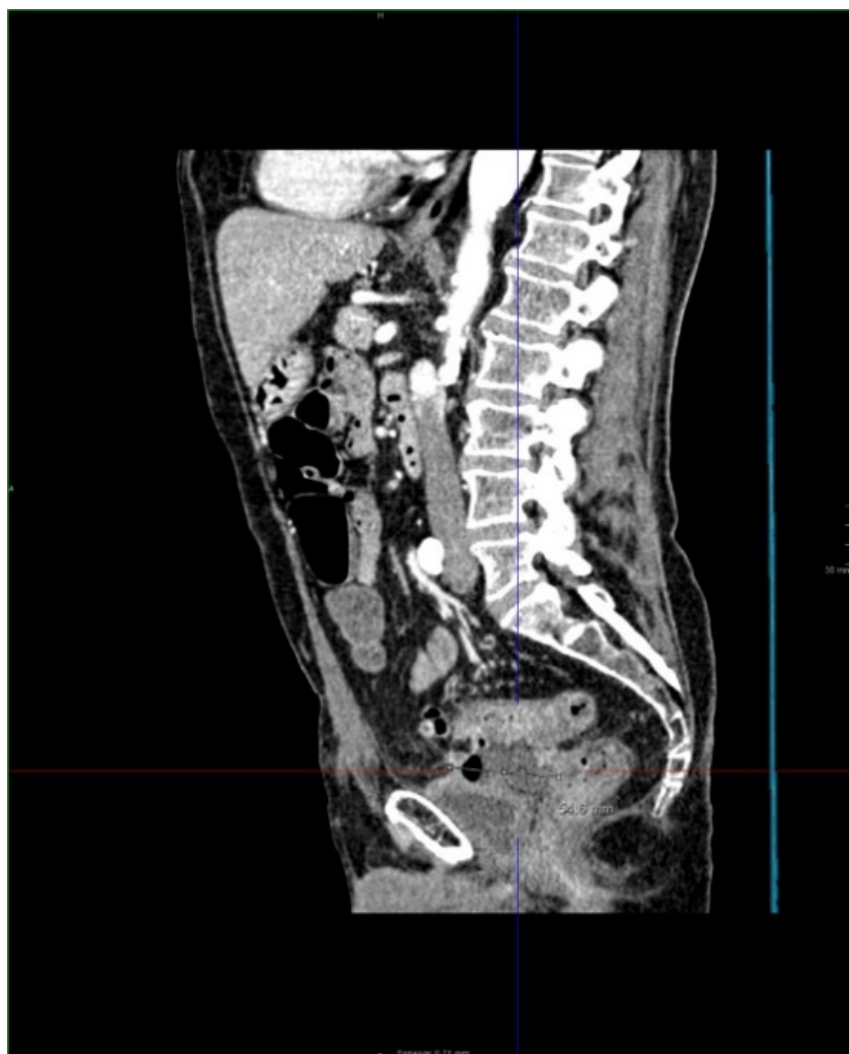
Procalcitonina, hemograma y estudio básico de coagulación. Los hallazgos típicos son la leucocitosis con neutrofilia asociado a un aumento de PCR. En casos graves se podrá asimismo objetivar desviación izquierda o coagulopatía. Asimismo se recomienda realizar un urianálisis, sobre todo en pacientes que refieran síndrome miccional.

Pruebas de imagen

- Radiografía de abdomen.
- Ecografía abdominal: posee una precisión diagnóstica del 97% si se utiliza un ecógrafo de alta resolución y un ecografista especializado. Tiene su utilidad en pacientes a los que no es posible la realización de un TAC (embarazadas, alergia a contrastes, IRC), así como para control evolutivo de pacientes que se traten de forma conservadora, pero tiene la limitación de pacientes obesos o con íleo asociado.
- TAC abdominal.

Inicialmente una radiografía simple de abdomen puede ayudarnos a descartar a excluir cuadros de litiasis renal u obstrucción intestinal, así como detectar perforaciones de víscera hueca. Sin embargo, para la confirmación diagnóstica la mayoría de guías internacionales recomiendan el TAC abdominal con contraste intravenoso como la prueba “gold standard”. Estos estudios tienen una sensibilidad del 98% con una especificidad del 99% y nos permiten evaluar tanto el grado de severidad como la presencia de abscesos o perforación.





Izquierda: Imagen de TC abdominal de diverticulitis aguda en Sigma.
Derecha: Absceso pericólico asociado.

Clasificación

CLASIFICACIÓN DE HINCHEY MODIFICADA		
0	Diverticulitis clínicamente moderada	
I	Ia	Inflamación pericólica confinada
	Ib	Inflamación pericólica confinada con absceso pericólico
II	Absceso pélvico, retroperitoneal o a distancia	
III	Peritonitis purulenta generalizada	
IV	Peritonitis fecaloidea generalizada	

Diagnóstico Diferencial

Habrà que realizarlo fundamentalmente con un càncer colorrectal, que puede presentar la misma clínica y hallazgos en las pruebas de imagen, por lo que será necesaria una colonoscopia una vez se haya resuelto el episodio de inflamación aguda.

Otras patologías a incluir son la colitis isquémica, la enfermedad inflamatoria intestinal, apendicitis aguda, síndrome de intestino irritable o patología ginecológica (enfermedad inflamatoria pélvica, absceso tuboovárico, embarazo ectópico...).

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

El tratamiento de la diverticulitis aguda es habitualmente médico.

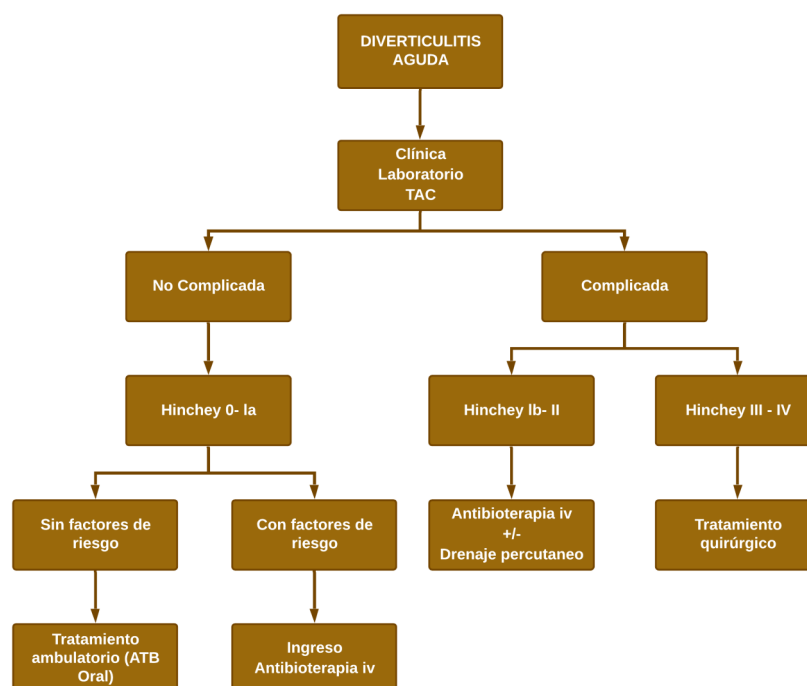
En casos de diverticulitis aguda no complicada (Hinchey 0 o Ia) es posible la realización de tratamiento ambulatorio con antibioterapia oral (habitualmente Amoxicilina-Acido Clavulánico 875/125 mg. cada 8 horas, o Ciprofloxacino 500 mg. cada 12 horas y Metronidazol 500 mg. cada 8 horas) durante 10-14 días, asociado a dieta líquida durante las primeras 48 horas.

Son condiciones indispensables para la realización de tratamiento ambulatorio la ausencia de signos de complicación en el TAC, la adecuada tolerancia oral, la ausencia de comorbilidades graves (IRC, inmunosupresión, patología cardíaca), así como el adecuado apoyo social. En estos casos, se requiere la realización de revisiones, habitualmente entre los 4 y 7 días tras el diagnóstico, que permitan identificar aquellos pacientes que no evolucionan favorablemente y que por tanto requieran un ingreso posterior.

En el caso de pacientes que no cumplan los criterios mencionados previamente, será necesario un ingreso hospitalario con tratamiento antibiótico intravenoso, reposo digestivo y analgesia. Los antibióticos elegidos han de cubrir gérmenes gram negativos y anaerobios. Entre las opciones iniciales a utilizar: Ceftriaxona 2 gr. cada 24 horas + Metronidazol 500 mg. cada 8 horas ó Ciprofloxacino 500 mg. cada 12 horas + Metronidazol 500 mg. cada 8 horas ó Piperacilina/Tazobactam 4 gr. cada 8 horas.

Los pacientes con abscesos asociados pueden requerir complementariamente un drenaje percutáneo por radiología intervencionista. No se ha determinado a partir de qué tamaño está indicada su realización, pero en general se establece que colecciones de hasta 3-4cm pueden resolverse con tratamiento médico.

Ante casos con perforación o peritonitis asociada, así como en aquellos en los que no exista mejoría a pesar del tratamiento médico, estará indicada una intervención quirúrgica de urgencia. Dependiendo de los hallazgos intraoperatorios se realizará una intervención de Hartmann, una resección con anastomosis primaria o un lavado con drenaje.



NO OLVIDAR

- Sospechar esta entidad ante la aparición de episodio agudo de dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda y fiebre.
- Cuidado con pacientes embarazadas, alérgicos al contraste o con deterioro de función renal al escoger la prueba de imagen más adecuada disponible.
- Ante la sospecha de diverticulitis aguda solicitar valoración urgente por la especialista de Cirugía.
- Si datos de SIRS o Sepsis abdominal realizar el diagnóstico e identificar las posibles complicaciones cuanto antes para poder iniciar tratamiento dirigido (tratamiento médico, intervencionismo y/o cirugía).
- Dejar al paciente en dieta absoluta e iniciar sueroterapia hasta confirmar diagnóstico y decidir actitud terapéutica.
- Ante la posibilidad de tratamiento quirúrgico, es importante ver cifras de hemoglobina por si existe anemia (cruzar y reservar concentrados de hematíes) o conocer la existencia de trombopenia o coagulopatía. Suspendir desde el inicio anticoagulantes y antiagregantes. Revertir anticoagulación si es necesaria la cirugía o si sangrado evidente.

BIBLIOGRAFÍA

- Biondo S., Fraccalvieri D., Enfermedad diverticular en Guía Clínica de la Asociación Española de Cirujanos 2ª edición. Arán Ediciones 2012
- Biondo S., LopezBorao J., Millan M., Kreisler E., Jaurrieta E. Current status of the treatment of acute colonic diverticulitis: A systematic review. *Colorectal Dis*, 14 (2012), pp. e1-e11
- Boermeester MA, Humes DJ, Velmahos GC, Søreide K. Contemporary Review of Risk-Stratified Management in Acute Uncomplicated and Complicated Diverticulitis. *World J Surg*. 2016 Oct;40(10):2537-45.
- Carabotti M, Annibale B. Treatment of diverticular disease: an update on latest evidence and clinical implications. *Drugs in Context* 2018; 7: 212526.
- Feingold D. Practice Parameters for the Treatment of Sigmoid Diverticulitis. *Dis Colon Rectum* 2014; 57: 284–294
- Rosado-Cobian Rafael. Enfermedad diverticular complicada: toma de posición sobre tratamiento ambulatorio, intervención de Hartmann, lavado-drenaje peritoneal y cirugía laparoscópica. Documento de consenso de la Asociación Española de Coloproctología y Sección de Coloproctología de la Asociación Española de Cirujanos. *Cir Esp* 2017;95:369-77
- Shabanzadeh DM. Antibiotics for uncomplicated diverticulitis. *Cochrane DatabaseSyst Rev*.2012 Nov 14;11:CD009092
- Stollman N, Smalley W, Hirano I; AGA Institute Clinical Guidelines Committee. American Gastroenterological Association Institute Guideline on the management of acute diverticulitis. *Gastroenterology*. 2015; 149:1944–9.
- Van Dijk ST, Bos K, de Boer MGJ, Draaisma WA, van Enst WA, Felt RJF, Klarenbeek BR, Otte JA, Puylaert JBCM, van Geloven AAW, Boermeester MA. A systematic review and meta-analysis of outpatient treatment for acute diverticulitis. *Int J Colorectal Dis*. 2018 May;33(5):505-512.